



COLLANA EDITORIALE

POLICY REPORT 03 • 2026

Prevenzione cardiovascolare: dalle strategie europee ai territori

Safe Hearts Plan, continuità assistenziale
e risposta alle emergenze cardiache

PREVENZIONE • ACCESSO • CONTINUITÀ

Sintesi esecutiva

La salute cardiovascolare richiede una politica capace di accompagnare le persone prima, durante e dopo la malattia. Una campagna informativa può favorire la consapevolezza; un controllo può identificare un rischio; una rete di emergenza può ridurre ritardi. Il valore pubblico nasce quando queste funzioni sono collegate e rendono possibile un intervento appropriato e continuativo.

Il Safe Hearts Plan, presentato dalla Commissione europea il 16 dicembre 2025, offre un quadro comune per prevenzione, diagnosi precoce e cura. Il suo sviluppo impone di passare da iniziative separate a percorsi misurabili. Il tema organizzativo centrale è stabilire chi prende in carico la persona dopo l'emersione di un bisogno e come il servizio verifica che il percorso sia stato completato. [1,2]

Cinque raccomandazioni del report

- 1. Collegare controllo e presa in carico.** Ogni iniziativa di valutazione del rischio dovrebbe prevedere informazione, restituzione dell'esito, invio appropriato e verifica del successivo accesso.
- 2. Agire sui fattori di rischio e sulle condizioni sociali.** La prevenzione deve rendere accessibili scelte salutari e servizi, con particolare attenzione alle persone difficili da raggiungere.
- 3. Rafforzare la risposta comunitaria.** Formazione, defibrillatori effettivamente accessibili, centrali operative e reti professionali devono funzionare come un sistema.
- 4. Misurare equità e continuità.** Il numero dei controlli e dei corsi non basta: occorre misurare accesso, follow-up, qualità e differenze territoriali.
- 5. Rendere trasparente la collaborazione.** Ruoli, finanziamenti, interessi e responsabilità vanno documentati fin dall'avvio.

Tesi di policy

Il cuore dell'attuazione non è aumentare indiscriminatamente il numero delle prestazioni. È ridurre le interruzioni tra bisogno riconosciuto e risposta appropriata. Un progetto piccolo ma verificabile, con responsabilità definite e risultati tracciabili, è preferibile a un programma esteso che misura solo la partecipazione.

Ambito e metodo

Il report integra fonti della Commissione europea, OECD, OMS, Istituto Superiore di Sanità ed European Resuscitation Council. Le proposte operative sono analisi originali di policy, da adattare alla programmazione sanitaria e alle competenze dei soggetti responsabili. Non vengono stimati risparmi o benefici clinici non documentati; non si fissano soglie diagnostiche o trattamenti individuali.

L'incontro del 17 marzo e il quadro epidemiologico

Il confronto promosso dalla Fondazione

Il 17 marzo 2026, alle 16:30, la Fondazione Boscacci ETS ha promosso a Bruxelles l'incontro "Science & Policy debate about EU Cardiovascular Plan", presso il Parlamento europeo, sala SPAAK 1C47, ospitato dall'eurodeputata Isabella Tovaglieri. La locandina indica Francesco Luongo, Massimo Ciccozzi e Stefano De Lillo tra i relatori e Fabio Boscacci come moderatore. Il resoconto della Fondazione richiama prevenzione cardiovascolare e capacità di risposta nelle emergenze cardiache. [9,10]

Il presente documento sviluppa quei temi con fonti aggiornate. Non ricostruisce dichiarazioni individuali o conclusioni collegiali in assenza di una trascrizione verificata. La sede parlamentare dell'incontro non è interpretata come un'approvazione del documento da parte del Parlamento europeo.

Le dimensioni del problema

Indicatore	Valore e perimetro	Fonte
Decessi cardiovascolari nell'UE	1,7 milioni nel 2022; circa un terzo di tutti i decessi.	OECD, 2025 [3]
Persone con malattie cardiovascolari nell'UE	Circa 62 milioni; stima riportata nel rapporto.	OECD, 2025 [3]
Onere economico nell'UE	282 miliardi di euro annui, stima riferita al 2021.	OECD, 2025 [3]

L'onere economico comprende assistenza sanitaria, assistenza sociale, cura informale e perdite di produttività. Non equivale alla sola spesa ospedaliera né a una somma integralmente recuperabile con uno specifico progetto. [3]

Interpretazione per le politiche pubbliche

Questi dati motivano una strategia che superi il singolo episodio assistenziale. La prevenzione produce valore quando identifica i bisogni con anticipo e rende possibile intervenire; la cura produce valore quando garantisce continuità; l'emergenza produce valore quando riduce i ritardi evitabili. Una valutazione economica locale deve comunque distinguere investimenti iniziali, costi ricorrenti, orizzonte temporale e risultati osservati. Non è corretto trasferire automaticamente stime europee al bilancio di un territorio.

Safe Hearts Plan: opportunità e stato dell'attuazione

Il quadro europeo

La Comunicazione COM(2025) 1024 final definisce un percorso europeo che comprende prevenzione lungo il corso della vita, identificazione precoce e assistenza alle persone con malattie cardiovascolari. Il piano combina iniziative su fattori di rischio, controlli, innovazione e disuguaglianze, nel rispetto delle responsabilità nazionali nell'organizzazione dei servizi. [1,2]

Tra gli obiettivi europei figura una riduzione del 25% della mortalità cardiovascolare prematura entro il 2035 rispetto al 2022. Si tratta di un obiettivo di programma, non di un risultato già conseguito né di una previsione del presente report. [1]

Aggiornamento successivo all'evento

Il 28 settembre 2026 la Commissione ha presentato COM(2026) 481 final, proposta di raccomandazione del Consiglio sui controlli cardiovascolari. Al momento del controllo delle fonti, il documento è indicato come **proposta**: non viene qui descritto come una raccomandazione già adottata dal Consiglio. La notizia è successiva all'incontro di marzo ed è riportata per aggiornare il quadro del paper. [4]

Dall'indirizzo europeo alla capacità operativa

Un programma europeo può favorire il coordinamento e la comparabilità. La sua realizzazione richiede però che ogni sistema definisca popolazione destinataria, criteri di accesso, organizzazione dell'offerta, collegamento con i servizi e sistemi di monitoraggio. È in questi passaggi che una strategia generale diventa un'esperienza concreta per il cittadino.

La proposta del report è utilizzare la cornice europea come riferimento per programmi territoriali con quattro condizioni: una responsabilità clinico-organizzativa identificata; un percorso di invio effettivamente disponibile; un sistema informativo proporzionato; una valutazione indipendente. La partnership con associazioni, enti del Terzo settore e comunità locali può ampliare l'accesso, purché non sostituisca le responsabilità dei servizi sanitari.

Un confine essenziale

La promozione di controlli appropriati non comporta che tutti debbano ricevere gli stessi esami con identica frequenza. La scelta delle valutazioni deve dipendere da evidenze, profilo di rischio e protocolli adottati dai responsabili sanitari. La comunicazione pubblica dovrebbe evitare di trasformare obiettivi di programma in prescrizioni individuali indiscriminate.

Prevenzione: accesso, fattori di rischio e follow-up

Una base scientifica consolidata

L'OMS identifica tra i principali fattori modificabili uso di tabacco, dieta non salutare, inattività fisica, consumo dannoso di alcol e inquinamento. Ipertensione, alterazioni dei lipidi, diabete e obesità contribuiscono al rischio e richiedono identificazione e gestione appropriata. La prevenzione comprende sia interventi sugli ambienti di vita sia assistenza alle persone. [5]

Per l'azione pubblica, la conseguenza è chiara: la responsabilità individuale deve essere sostenuta da condizioni che rendano praticabili le scelte salutari. Un messaggio informativo ha scarsa utilità se la persona non può accedere a un servizio, comprendere l'esito o sostenere il percorso successivo.

Il problema del controllo senza percorso

La proposta organizzativa del report è considerare incompleta un'iniziativa che termina con la consegna di un valore. L'esito deve essere spiegato; l'eventuale necessità di approfondimento deve trovare un canale definito; i tempi di accesso devono essere osservabili. Chi non risponde o non completa il percorso dovrebbe poter essere ricontattato attraverso modalità rispettose e proporzionate.

I programmi territoriali dovrebbero distinguere l'offerta universale di informazione dall'intervento mirato su gruppi con bisogni specifici. La scelta dei destinatari richiede una valutazione esplicita di benefici, limiti e capacità dei servizi. La crescita del numero di controlli non può essere considerata, da sola, prova di miglioramento della salute.

Leggere correttamente i dati italiani

La sorveglianza PASSI offre indicatori utili per osservare fattori di rischio e comportamenti nella popolazione adulta. L'ISS chiarisce che diverse misure si basano su dichiarazioni degli intervistati e che la diagnosi riferita non coincide necessariamente con la prevalenza rilevabile mediante misurazioni cliniche. I dati sono utili per differenze territoriali e tendenze, ma richiedono cautela nell'interpretazione. [6,7]

Nel presente report non vengono riproposte come attuali percentuali italiane pubblicate molti anni fa. Per un progetto regionale, si propone di usare l'ultima finestra di sorveglianza disponibile, indicare l'età della popolazione osservata e affiancare i dati riferiti a informazioni assistenziali aggregate. In questo modo la programmazione evita di confondere popolazioni, anni e definizioni diverse.

Emergenze cardiache: costruire un sistema che risponde

Distinguere prevenzione e risposta all'evento acuto

Prevenire le malattie cardiovascolari e migliorare la risposta all'arresto cardiaco sono funzioni complementari, con indicatori diversi. L'infarto e l'arresto cardiaco non sono sinonimi. Il primo riguarda il flusso di sangue al muscolo cardiaco; il secondo la perdita improvvisa di una funzione circolatoria efficace. Non ogni infarto determina un arresto, ma può provocarlo. [11]

L'European Resuscitation Council, nella catena della sopravvivenza aggiornata al 2025, collega prevenzione e riconoscimento precoce, rianimazione e defibrillazione tempestive, assistenza professionale e recupero a lungo termine. La prospettiva include il sostegno ai sopravvissuti e a chi li assiste. [8]

La proposta: passare dalla dotazione alla disponibilità

Il numero di defibrillatori installati non descrive da solo la capacità di risposta. Un dispositivo può essere presente ma non accessibile all'orario necessario, non individuabile, non mantenuto o non conosciuto dalla rete operativa. La mappa delle dotazioni dovrebbe essere accompagnata da una verifica periodica di accessibilità, manutenzione e responsabilità.

La formazione deve essere considerata una funzione continuativa. Il report propone percorsi riconosciuti, richiami pratici e verifiche delle competenze, organizzati con i soggetti responsabili dell'emergenza. Una simulazione locale può far emergere problemi di segnaletica, accesso e coordinamento che non risultano da un elenco di partecipanti.

Un pacchetto organizzativo territoriale

Inventario: censire dispositivi, luoghi, orari, referenti e stato di manutenzione.

Collegamento operativo: integrare le informazioni con la rete di emergenza secondo le modalità definite dalle autorità competenti.

Formazione: identificare gruppi prioritari e pianificare aggiornamenti con istruttori qualificati.

Valutazione: distinguere controlli di processo, tempi osservati ed esiti clinici con definizioni condivise.

Recupero: prevedere informazioni e orientamento per sopravvissuti, familiari e soccorritori.

La proposta concerne l'organizzazione dei servizi. Le procedure di soccorso individuale devono essere apprese attraverso formazione appropriata e seguite secondo le indicazioni dei servizi di emergenza; il report non costituisce un manuale operativo.

Un modello territoriale di attuazione

Il report propone un progetto pilota modulare di dodici mesi. Tempi e passaggi sono ipotesi di lavoro, non un programma già approvato o finanziato. La scelta dei territori dovrebbe considerare bisogni, accessibilità, capacità dei servizi e qualità dei dati disponibili.

Fase proposta	Attività	Condizione per procedere
Mesi 1-3 / progettazione	Definizione dei bisogni, popolazione, responsabilità, percorso di invio, budget e indicatori.	Servizio clinico responsabile e capacità di follow-up documentati.
Mesi 4-6 / avvio controllato	Informazione, primi accessi, verifica della restituzione degli esiti; ricognizione della rete di emergenza.	Nessun ampliamento prima di verificare accesso, invio e sostenibilità.
Mesi 7-9 / correzione	Analisi delle rinunce e delle interruzioni; adattamento di orari, comunicazione e accompagnamento.	Modifiche documentate; confronto tra gruppi e territori.
Mesi 10-12 / valutazione	Valutazione di fattibilità, equità, costi e qualità; decisione su prosecuzione o revisione.	Rapporto pubblico con risultati, limiti e risorse necessarie.

Chi fa che cosa

Le istituzioni sanitarie definiscono gli standard e assicurano la presa in carico. I professionisti individuano le valutazioni appropriate e ne interpretano gli esiti. Gli enti territoriali possono facilitare accessibilità e comunicazione. Associazioni e Terzo settore possono contribuire a raggiungere persone poco intercettate dai canali ordinari. I soggetti tecnici forniscono strumenti e supporto nei limiti delle responsabilità concordate.

Il possibile contributo della Fondazione

Per una Fondazione impegnata nel dialogo istituzionale, il contributo più utile è facilitare il confronto tra soggetti, produrre analisi, rendere comprensibili le opzioni e favorire una valutazione pubblica. Il presente report non propone che la Fondazione sostituisca il servizio sanitario nella diagnosi, nel trattamento o nella gestione delle emergenze.

Governance, dati e valutazione

Trasparenza e indipendenza

Ogni iniziativa dovrebbe pubblicare finalità, soggetti responsabili, fonti di finanziamento e ruolo dei partner. I potenziali interessi devono essere dichiarati; la scelta delle priorità sanitarie e l'interpretazione dei risultati devono restare verificabili. La presenza di un finanziatore non dovrebbe trasformare un programma di salute pubblica in un canale promozionale di prodotti.

Uso proporzionato dei dati

La raccolta dovrebbe limitarsi alle informazioni necessarie alle finalità dichiarate. Per il monitoraggio pubblico si propone l'uso di dati aggregati e la definizione preventiva di responsabilità, accessi, tempi di conservazione e misure di sicurezza da parte dei soggetti competenti. La progettazione tecnica deve essere verificata rispetto al quadro normativo applicabile, prima dell'avvio. Questa indicazione è una proposta di governance, non una valutazione legale di un sistema già esistente.

Indicatori proposti

Dimensione	Indicatore	Come leggerlo
Accesso	Persone raggiunte e quota che accede / popolazione eleggibile definita.	Registrare il denominatore; non confondere iscritti e popolazione.
Continuità	Quota degli invii con accesso successivo documentato; tempo tra invio e accesso.	Distinguere bisogno clinico, appropriatezza e capacità del servizio.
Equità	Differenze di accesso e completamento per territorio e gruppi pertinenti.	Usare categorie proporzionate e proteggere gruppi con pochi casi.
Emergenza	Dotazioni accessibili e mantenute; formazione aggiornata; dati di rete disponibili.	La dotazione è processo, non una misura di sopravvivenza.
Esiti e qualità	Esiti definiti dai responsabili clinici; esperienza dei cittadini; eventi indesiderati.	Evitare attribuzioni causali senza disegno di valutazione adeguato.

Non sono fissati target clinici arbitrari. I valori obiettivo andrebbero concordati dopo una baseline, con responsabili sanitari e valutatori. I primi dodici mesi possono verificare fattibilità e continuità; non bastano automaticamente a dimostrare una riduzione della mortalità attribuibile al progetto.

Agenda di policy e conclusioni

Tre decisioni necessarie

Definire la responsabilità del percorso. L'accesso a un'iniziativa di prevenzione deve avere una destinazione riconoscibile. Occorre sapere quale soggetto organizza la restituzione dell'esito, chi riceve l'eventuale invio e chi verifica che la persona non resti senza risposta.

Finanziare la continuità. Il budget dovrebbe coprire progettazione, personale, informazione, accessibilità, follow-up, manutenzione degli strumenti e valutazione. Un evento pubblico può essere parte del programma, ma non ne esaurisce il costo né la funzione. Prima di ampliare l'offerta occorre verificare se i servizi possono sostenere la domanda generata.

Rendere leggibili i risultati. Un rapporto periodico dovrebbe spiegare quante persone sono state raggiunte, quali bisogni sono emersi, quali passaggi sono stati completati e quali ostacoli persistono. La pubblicazione dei limiti rafforza la credibilità del progetto e consente ai cittadini di valutarne l'utilità.

Una comunicazione responsabile

La comunicazione cardiovascolare dovrebbe spiegare il senso delle valutazioni appropriate, promuovere la comprensione dei fattori di rischio e orientare verso i servizi. Dovrebbe evitare promesse di protezione assoluta, risultati clinici non misurati e messaggi che riducono ogni scelta a un esame o a un dispositivo. Il linguaggio va adattato alla capacità di comprensione e alle condizioni di accesso della popolazione.

Una prospettiva per il dialogo europeo

Il confronto promosso dalla Fondazione a Bruxelles può sostenere una discussione che collega istituzioni, professionisti e società civile. Il valore di questo dialogo consiste nel far emergere le condizioni concrete dell'attuazione: persone che i servizi non raggiungono, invii che non vengono completati, strumenti che non sono disponibili quando servono, dati che non consentono di valutare gli esiti.

Conclusione

Il Safe Hearts Plan offre un'opportunità per organizzare la prevenzione cardiovascolare come una funzione stabile della salute pubblica. Il presente report propone di concentrarne l'attuazione su accesso, continuità, capacità di risposta ed equità. La qualità del programma si misurerà nella possibilità di riconoscere un bisogno e ottenere una risposta appropriata, attraverso responsabilità chiare e risultati verificabili.

La prevenzione cardiovascolare può diventare un'infrastruttura sociale: una rete di competenze e servizi disponibile nel tempo, capace di accompagnare le persone e di sostenere le comunità. Per realizzarla occorrono programmazione, risorse e valutazione, insieme a un dialogo pubblico fondato su evidenze e trasparenza.

Fonti e nota editoriale

- [1] Commissione europea. Communication on an EU cardiovascular health plan: the Safe Hearts Plan. COM(2025) 1024 final, 16 dicembre 2025. Per obiettivi e quadro strategico: pp. 7-8 del documento, sezione 2. [Fonte online](#).
- [2] Commissione europea, DG SANTE. Cardiovascular health. Quadro delle iniziative e aggiornamenti sul Safe Hearts Plan. [Fonte online](#).
- [3] OECD (2025). The State of Cardiovascular Health in the European Union. Executive summary. DOI: 10.1787/ea7a15f4-en. Dati di mortalità 2022 e costo economico 2021. [Fonte online](#).
- [4] Commissione europea. COM(2026) 481 final - Proposal for a Council Recommendation on cardiovascular health checks: an EU approach to early detection and screening. 28 settembre 2026. [Fonte online](#).
- [5] OMS. Cardiovascular diseases (CVDs). Scheda informativa, 31 luglio 2025. [Fonte online](#).
- [6] Istituto Superiore di Sanità, EpiCentro. Indicatori PASSI: pressione arteriosa. Definizioni, popolazione di riferimento e limiti. [Fonte online](#).
- [7] Istituto Superiore di Sanità, EpiCentro. Rischio cardiovascolare: dati e metodologia di sorveglianza PASSI. Utilizzato per la metodologia, non come fonte di percentuali italiane attuali. [Fonte online](#).
- [8] European Resuscitation Council. Chain of Survival, Guidelines 2025. [Fonte online](#).
- [9] Fondazione Boscacci ETS. Resoconto pubblico dell'incontro del 17 marzo 2026, pubblicato sul profilo istituzionale LinkedIn; testo fornito anche dalla Fondazione per questa elaborazione. [Fonte online](#).
- [10] Fondazione Boscacci ETS. Locandina "Science & Policy debate about EU Cardiovascular Plan", 17 marzo, ore 16:30. Consultabile nella pagina Eventi del sito. [Fonte online](#).
- [11] American Heart Association. Heart Attack and Sudden Cardiac Arrest Differences. Per la distinzione tra infarto e arresto cardiaco. [Fonte online](#).

Nota editoriale

Fonti consultate il 3 ottobre 2026. L'aggiornamento del settembre 2026 è distinto dall'evento del marzo 2026. Le qualifiche riportate per i partecipanti si riferiscono ai materiali dell'incontro e non sono usate per attestare incarichi attuali. Non sono attribuite citazioni ai relatori. I dati sono presentati con anno e perimetro; le raccomandazioni operative sono proposte del report. Non sono dichiarati finanziamenti, accordi di attuazione o revisioni scientifiche non documentati.